Asma · Cartão de Plantão

Para consultar à beira do leito; confira no protocolo do serviço

Gravidade da crise [ASBAI]

	Leve	Moderada	Grave
Fala	Frases	Frases curtas	Palavras
Acessória	Não	Sim	Acentuada
SatO2	> 95%	90–95% (< 5 a: 92–95)	< 90% (< 5 a: < 92)
PFE	≥ 70%	40–69%	< 40%

Tórax silencioso, sonolência, cianose, bradicardia: ameaça à vida.

1ª hora [MS] [ASBAI] [GINA]

O2	1–3 L/min; SatO2 ≥ 94%
Salbutamol	100 mcg/jato, espaçador, 1 jato por vez: 4–10 jatos 20/20 min ×3 (5–10 kg 4; 10–20 kg 6; > 20 kg 8). Nebulizar se não coopera (≤ 5 a: 2,5 mg)
Ipratrópio	Moderada/grave, com SABA: neb. 125–250 mcg (< 4 a) ou 250–500 mcg (≥ 4 a), 20/20 min ×3
Reavaliar	A cada 20–30 min

Corticoide [ASBAI] [GINA] [MS]

Prednisolona VO **1–2 mg/kg/dia**, 1×/dia: máx. **20 mg** (< 2 a), **30 mg** (2–5 a), **40 mg** (6–11 a), 3–5 dias; adolescente 40–50 mg, 5–7 dias. Ou dexametasona VO 0,3–0,6 mg/kg (máx. 12 mg), 1–2 dias. IV só se não engole.

Refratária [ASBAI] [GINA]

Magnésio IV > 2 anos: **25–75 mg/kg** em 20 min, máx. 2–2,5 g (GINA: 40–50 mg/kg, máx. 2 g). Gasometria se PFE < 50%, SatO2 < 92% ou má evolução.

Destino [ASBAI]

Internar	Sem resposta em 2 h · fadiga · tórax silencioso · O2 ainda após 1 h · asma quase fatal prévia
UTI	Não fala · sonolência · hipoxemia com O2 · hipercapnia
Intubar	Alteração mental · PaO2 < 60 com FiO2 100% · acidose progressiva · PCR

Alta [ASBAI] [MS] [GINA]

Estável, sem O2, comendo e bebendo. Alívio sob demanda · corticoide até o fim · **iniciar ou intensificar CI** · técnica conferida · plano escrito · retorno em 1–2 dias (adolescente 2–7). Voltar se SABA em < 4 h.

Manutenção [MS]

≤ 5 a: CI diário em dose baixa (beclometasona 100 mcg/dia) se > 2×/sem ou crise grave no ano. 6–11 a: CI quando usar SABA → CI diário → CI-LABA. ≥ 12 a: budesonida-formoterol 200/6 sob demanda; MART; máx. 12 inalações/dia.

Não prescrever

Antibiótico de rotina · aminofilina · sedativo · RX de rotina · magnésio nebulizado · corticoide oral iniciado pelos pais · CI-salmeterol como alívio · alta só com SABA.